Клинические рекомендации

Крапивница

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**L50** — Крапивница **L50.0** — Аллергическая крапивница **L50.1** — Идиопатическая крапивница **L50.2** — Крапивница, вызванная воздействием низкой или высокой температуры **L50.3** — Дерматографическая крапивница **L50.4** — Вибрационная крапивница **L50.5** — Холинергическая крапивница **L50.6** — Контактная крапивница **L50.8** — Другая крапивница **L50.9** — Крапивница неуточненная **T78.3** — Ангионевротический отек
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 19.07.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/264_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Этиология, патогенез и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика **4**

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Жалобы и анамнез. Физикальное обследование 4

3.3 Лабораторные исследования 5

3.4 Ларингоскопия 5

3.5 Оценка активности и консультации 5

3.6 Дифференциальная диагностика 6

4. Лечение **6**

4.1 Устранение причин 6

4.2 Острая крапивница и ангиоотёк 6
4.3 Хроническая крапивница: первая линия 6
4.4 Вторая и третья линии 7
4.5 Беременность и лактация 7
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7
5.1 Профилактика и диспансерное наблюдение 7
5.2 Показания к госпитализации 8
6. Источник и актуальность 8
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Крапивницей называют группу заболеваний, при которых развиваются волдыри, ангиоотёки или то и другое вместе. Острая крапивница длится **менее 6 недель**, хроническая — **более 6 недель**.
- Диагноз клинический: обратимые волдыри и (или) ангиоотёки. При острой крапивнице обследование не проводится, если нет указаний на провоцирующий фактор; при хронической — ограниченный обязательный объём.
- Основа лечения — неседативные антигистаминные препараты второго поколения, при хронической крапивнице — регулярно, а не по потребности. При недостаточном эффекте дозу повышают до четырёхкратной, затем добавляют омализумаб, затем #циклоспорин.
- При ангиоотёке гортани с угрозой жизни показана экстренная интубация трахеи или трахеостомия; если крапивница или ангиоотёк — проявление анафилаксии, помощь оказывается по рекомендациям «Анафилактический шок».
- Госпитализации подлежат пациенты с ангиоотёком гортани и риском асфиксии, тяжёлой острой крапивницей, анафилаксией, торпидным к амбулаторному лечению обострением.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

1. **крапивница** — группа заболеваний, характеризующихся развитием волдырей, ангиоотёков или того и другого вместе
2. **ангиоотёк** — диффузный отёк с захватом всей дермы и подкожной жировой клетчатки и (или) слизистой оболочки и подслизистого слоя

Состояния, при которых волдыри являются симптомом (кожные тесты, аутовоспалительные синдромы, анафилаксия, наследственный ангиоотёк), к крапивнице не относятся.

2.2 Этиология, патогенез и эпидемиология

Медиаторы активированных тучных клеток (гистамин, серотонин, фактор активации тромбоцитов, цитокины) вызывают вазодилатацию, повышение проницаемости капилляров и выход плазмы. Почти у половины пациентов с хронической крапивницей определяются IgG-аутоантитела к IgE (5–10%) и к FcεRI (35–40%). Дегрануляцию вызывают также комплемент, нейропептиды, тепло, холод, НПВП, контрастные средства, опиоиды.

Распространённость острой крапивницы — 20%, у детей — 2,1–6,7%. Хроническая спонтанная крапивница поражает 0,5–5% населения, женщины болеют чаще.

2.3 Классификация

Крапивницу классифицируют по продолжительности, типам и подтипам; у одного пациента возможны две и более формы. Индуцируемая крапивница может протекать хронически и включена в классификацию хронической.

1. **острая** — волдыри и (или) ангиоотёки в период **менее 6 недель**; каждый волдырь существует **не более 24 часов**
2. **хроническая** — волдыри ежедневно или почти ежедневно **более 6 недель**; спонтанная (идиопатическая) — самая частая разновидность

2.4 Клиническая картина

Признаки волдыря

1. центральный отёк разных размеров, почти всегда окружённый эритемой;
2. зуд, иногда жжение;
3. обратимость: волдырь исчезает бесследно **в течение 1–24 часов**.

Волдыри сначала бледно-розовые, при нарастании отёка, особенно у детей, могут становиться фарфорово-белыми. Сливаются в местах трения одеждой; на лице могут почти не выступать над кожей.

Признаки ангиоотёка

1. быстро развивающийся отёк глубоких слоёв дермы, подкожной клетчатки и подслизистого слоя;
2. чувство распирания и болезненности чаще, чем зуд;
3. возможное отсутствие эритемы; кожа бледная, плотная, ямка при надавливании не образуется;
4. разрешение **в срок до 72 часов**.

Поражаются ткани с рыхлой клетчаткой: веки, губы, щёки, слизистая оболочка полости рта, языка, гортани; при рецидивах нередко те же локализации.

1. **отёк слизистой оболочки носа** — чихание, затруднение носового дыхания
2. **губы и язык** — резкое асимметричное увеличение, нарушение речи
3. **гортань** — осиплость голоса вплоть до афонии из-за отёка голосовых складок, затем затруднение дыхания

Острая крапивница в большинстве случаев остаётся единственным эпизодом. Хроническая течёт волнообразно без прогрессирующего ухудшения: ремиссия в течение года наступает у 10–30%, за 3 года — у 30–50%, после 5 лет — у 40–70% пациентов; сопутствующий ангиоотёк связан с большей длительностью.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз крапивницы устанавливается по наличию обратимых волдырей и (или) ангиоотёков; лабораторное подтверждение требуется только для выявления причины. Обследование начинают с анамнеза, физикального обследования и основных анализов, исключающих тяжёлые системные заболевания.

3.2 Жалобы и анамнез. Физикальное обследование

Что уточняют

1. вид, размер, локализацию и длительность элементов, зуд, боль; наличие и локализацию ангиоотёков;
2. начало и длительность эпизода, цикличность появления элементов;
3. эффективность антигистаминных препаратов и предшествующего лечения;
4. связь с приёмом ацетилсалициловой кислоты, НПВП, ингибиторов АПФ, пищи, физическими стимулами, стрессом;
5. атопические заболевания, крапивницу в личном и семейном анамнезе, хронические заболевания, поездки, профессию и хобби.

Измеряют АД, ЧСС, температуру, оценивают периферические лимфатические узлы, печень, селезёнку, лёгкие, сердце, брюшную полость: это помогает выявить заболевания, связанные с крапивницей.

3.3 Лабораторные исследования

При острой крапивнице обследование не рекомендуется, кроме случаев указания в анамнезе на провоцирующий фактор. При хронической обследование проводится всем для выявления причины, в ограниченном обязательном объёме.

Обязательный объём при хронической крапивнице

1. общий анализ крови: воспалительная реакция, эозинофилы, базофилы;
2. СРБ;
3. общий IgE;
4. IgG-антитела к тиреопероксидазе.

По показаниям

1. биохимический анализ крови;
2. исследования на паразитарную инвазию, Helicobacter pylori и вирусные инфекции.

1. антинуклеарные антитела — при подозрении на системный аутоиммунный процесс;
2. C1-ингибитор и его функциональная активность — при изолированных ангиоотёках.

1. C3, C4, C1q и биопсия кожи — при подозрении на уртикарный васкулит;
2. внутрикожный тест с аутосывороткой — для выявления функциональных аутоантител.

Провокационные тесты при индуцированной крапивнице

1. холодовой и тепловой;
2. с давлением (замедленная крапивница от давления);
3. с ультрафиолетом и видимым светом (солнечная);
4. на дермографизм;
5. аквагенный;
6. с физической нагрузкой (холинергическая).

Антигистаминные препараты отменяют **за 48 часов** до тестов. Детям тесты не запрещены, но не стандартизованы.

3.4 Ларингоскопия

Показания к ларингоскопии при хронической крапивнице

1. подозрение на ангиоотёк гортани;
2. вовлечение ротоглотки;
3. отёк лица и губ без чётких данных за отёк гортани — индивидуально.

Выполняют фиброларингоскопию или видеоларингоскопию; исследование проводит оториноларинголог или другой специалист для дифференциальной диагностики и выбора вмешательства.

3.5 Оценка активности и консультации

1. **UAS7** — индекс активности крапивницы за 7 дней: число высыпаний и интенсивность зуда, оценка пациентом каждые 24 часа
2. **AAS** — оценка активности ангиоотёков
3. **UCT** — тест контроля крапивницы за последние 4 недели
4. **DLQI** — качество жизни, **с 16 лет**

У детей валидированных инструментов нет; чаще применяют UAS7.

При хронической крапивнице показана консультация аллерголога-иммунолога и (или) дерматовенеролога. Острую крапивницу и стандартные случаи хронической при достигнутом контроле может вести педиатр или терапевт.

3.6 Дифференциальная диагностика

Заболевания с уртикарными высыпаниями

1. **уртикарный васкулит** — волдыри сохраняются более 24 часов, пурпура, гиперпигментация, жжение и боль чаще зуда; диагноз — по биопсии
2. **пигментная крапивница (мастоцитоз)** — красно-коричневые пятна и папулы, симптом Унны — Дарье; чаще у детей
3. **аутовоспалительные синдромы (CAPS, синдром Шнитцлер)** — лихорадка, уртикарная сыпь, поражение суставов, повышение острофазовых маркеров
4. **другие** — буллёзный пемфигоид, многоформная эритема, Т-клеточная лимфома кожи, боррелиоз, фиксированная лекарственная сыпь, СКВ, синдром Свита

---

4. Лечение

4.1 Устранение причин

1. отменить или заменить подозреваемые лекарственные препараты (ингибиторы АПФ, НПВП);
2. лечить выявленные инфекционные и воспалительные процессы, паразитарную инвазию.

При доказанной пищевой аллергии исключают причинные продукты; длительные ограничительные диеты при хронической спонтанной крапивнице не рекомендуются.

При индуцированных формах избегают соответствующего триггера: перегревания, охлаждения, давления на кожу, прямого солнца (фотозащита SPF 50+).

4.2 Острая крапивница и ангиоотёк

Препаратами выбора являются неседативные антигистаминные средства второго поколения.

Седативные препараты первого поколения парентерально — только по особым показаниям (генерализованная крапивница при стабильной гемодинамике): клемастин **с 1 года** в/м, **с 18 лет** в/м или в/в; хлоропирамин **с 1 месяца** в/м. Детям **до 6 месяцев** коротким курсом — диметинден 0,1 мг/кг в сутки в 3 приёма.

При отсутствии эффекта антигистаминных препаратов назначают глюкокортикоиды минимальным курсом; постепенная отмена при коротком курсе не нужна.

1. взрослые: преднизолон внутрь 20–50 мг в сутки, **до 10 дней**;
2. дети: преднизолон 1–2 мг/кг в сутки, **3–7 суток**;
3. тяжёлый ангиоотёк у взрослых, требующий госпитализации: #метилпреднизолон 60–80 (125) мг внутривенно, затем внутрь 5–7 дней.

При жизнеугрожающем ангиоотёке гортани выполняется экстренная интубация трахеи или трахеостомия; показание определяют по результатам клинического обследования. Пациентам с индуцированной крапивницей, перенёсшим анафилаксию, необходимо иметь при себе противошоковый набор с раствором эпинефрина 0,1% 1,0 мл.

4.3 Хроническая крапивница: первая линия

Неседативные антигистаминные препараты второго поколения принимают регулярно, а не по потребности; при индуцированных формах — перед ожидаемым действием триггера.

Седативные препараты первого поколения без особых показаний не рекомендуются: седация, нарушение координации, холинолитические эффекты, тахифилаксия.

Стандартные дозы

1. дезлоратадин: 6–12 месяцев — 1 мг; 1–5 лет — 1,25 мг; 6–11 лет — 2,5 мг; с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки;
2. левоцетиризин: 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки;
3. лоратадин: 2–12 лет — 5 мг (масса до 30 кг) или 10 мг; старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки;
4. цетиризин: 6–12 месяцев — 2,5 мг; 1–2 года — 2,5 мг 2 раза; 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз; старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки;
5. старше 12 лет: фексофенадин 180 мг, эбастин 10–20 мг, рупатадин 10 мг, биластин 20 мг 1 раз в сутки.

Повышение дозы при неполном эффекте

1. взрослым — от двукратной до четырёхкратной; дальше четырёхкратной не увеличивают;
2. детям — с осторожностью **до двукратной**;
3. повышают дозу одного препарата, не комбинируя разные антигистаминные средства.

Повышение дозы не зарегистрировано, кроме эбастина — в 2 раза **с 15 лет**.

4.4 Вторая и третья линии

Омализумаб добавляют пациентам **с 12 лет** с хронической спонтанной крапивницей.

1. показание: симптомы сохраняются **более 2–4 недель** на увеличенной дозе антигистаминных препаратов или нестерпимы;
2. доза: 300 мг подкожно **1 раз в 4 недели**, курс **не менее 6 месяцев**;
3. при недостаточном ответе по решению врачебной комиссии — #омализумаб до 600 мг и (или) интервал 2 недели.

Если на фоне антигистаминных препаратов и омализумаба контроль не достигнут **за 6 месяцев** (или раньше при нестерпимых симптомах, либо при отсутствии омализумаба), добавляют #циклоспорин. Лечение проводят врачи с опытом иммуносупрессивной терапии, с постоянным контролем функции почек, печени и АД.

При тяжёлом обострении хронической крапивницы применяют короткий курс глюкокортикоидов в тех же дозах, что при острой крапивнице; длительные курсы не рекомендуются из-за побочных эффектов.

4.5 Беременность и лактация

У беременных и кормящих применяют тот же алгоритм с осторожностью и оценкой пользы и риска. Препаратами первой линии являются неседативные антигистаминные средства второго поколения: лоратадин с возможной экстраполяцией на цетиризин и левоцетиризин. Безопасность повышенных доз у беременных и кормящих не изучена.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика и диспансерное наблюдение

Профилактика обострений

1. устранение физических и иных триггеров: холод, тепло, нагрузка, ингибиторы АПФ, НПВП;
2. контроль активности по анкетам UAS7, UCT, AAS;
3. базисная терапия.

Вакцинация проводится по индивидуальному плану в период контроля заболевания, не в обострение.

Всех пациентов (законных представителей) обучают: причины, симптомы, обследование, лечение и контроль крапивницы, ведение дневника.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. тяжёлая острая крапивница и ангионевротический отёк гортани с риском асфиксии;
2. крапивница, сопровождающая анафилаксию;
3. тяжёлое обострение хронической крапивницы и ангиоотёк, торпидные к амбулаторному лечению.

Как правило, пациентов госпитализируют в аллергологическое, дерматовенерологическое, педиатрическое или терапевтическое отделение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Крапивница»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 19.07.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	264_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Российское общество дерматовенерологов и косметологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации не выявлено.